

22 - 02- Les cancers de la voie biliaire - Pr. Narjis

Bonjour à tous. Le cours que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le dernier cours des quatre chapitres que j'ai à traiter avec vous. Pour conclure, nous aurons à traiter d'une pathologie qui, heureusement, n'est pas très fréquente, mais qu'il faut connaître en tant qu'étudiant de troisième année.

Ce sont les cancers de la voie biliaire, traités par ma main, professeur Narjis Youssef, professeur de chirurgie générale et digestive au CHU Mohamed VI de Marrakech. Alors, en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que les cancers des voies biliaires sont des tumeurs malignes de la vésicule biliaire, des voies biliaires intrahépatiques ou des voies biliaires extrahépatiques. Donc, à chaque fois qu'on nous rend des voies biliaires, elles peuvent être le siège de cancers.

On les appelle également cholangiocarcinomes. C'est une notion qui est importante. Si vous revenez un petit peu au cours, au chapitre que nous avons vu précédemment, qui sont les tumeurs hépatiques du foie, nous avons vu qu'au sein des tumeurs malignes primitives, au sein des cancers primitifs, nous avons deux entités.

Nous avons le carcinome hépatocellulaire, qui est une tumeur qui se développe à partir de l'hépatocyte. Et à côté, nous avons les cholangiocarcinomes. Les cholangiocarcinomes, ce sont les cancers des voies biliaires.

Elles peuvent toucher soit la vésicule biliaire, soit les voies biliaires intrahépatiques, soit les voies biliaires extrahépatiques. Dans 90% des cas, il s'agit d'adénocarcinomes. Ce sont des tumeurs épithéliales.

Ce sont heureusement des tumeurs qui sont rares. Ce ne sont pas des tumeurs qui sont très fréquentes. Mais on les traite à part, dans un chapitre à part, parce que ce sont des tumeurs qui sont graves.

Malheureusement, chez ces patients-là, lorsque le diagnostic est posé, le traitement est très délicat. Le traitement est très délicat parce que ce sont des tumeurs qui ont un pronostic très fâcheux, très réservé. Nous allons le développer par la suite.

Là aussi, comme pour la majorité des tumeurs hépatiques, l'imagerie a une place qui est extrêmement importante. Elle permettra d'orienter le diagnostic, de caractériser le diagnostic vers ces tumeurs biliaires du foie. Et comme pour les tumeurs hépatiques, ce sont des patients qui auront un traitement, une prise en charge multidisciplinaire.

C'est un chapitre qui fait intervenir à la fois les chirurgiens, les gastroenterologues, les radiologues, les réanimateurs. C'est un chapitre qui est vraiment multidisciplinaire à proprement parler. Le plan que nous allons suivre pour traiter cette question, c'est un plan qui est assez

classique, après avoir vu ensemble l'introduction.

Nous verrons les rappels, notamment le rappel anatomique. Nous verrons les classifications de ces tumeurs des foies biliaires. Nous verrons le volet épidémiologique.

Nous parlerons de fréquences et de facteurs de risque. Nous verrons quels sont les moyens diagnostiques pour arriver au diagnostic positif d'un cancer des foies biliaires. Comme il s'agit d'un cancer, l'étape suivante après le diagnostic, c'est bien sûr le bilan préthérapeutique qu'il faudra suivre pour traiter ces patients.

Ensuite, nous verrons le traitement. Quels sont les traitements curatifs? Quels sont les traitements palliatifs? Quelles sont les principales indications à proposer chez ces patients-là? Pour vous dire, c'est un cours qui n'est pas très lent. Il y aura une trentaine de diapositives.

Par rapport aux autres cours, c'est un cours qui n'est pas très lent. C'est volontairement fait pour ne pas rentrer dans les détails et les répétitions. Nous allons nous focaliser sur les choses qui sont essentielles.

Tout d'abord, commençons par les rappels. En matière de rappel, nous allons commencer par le rappel anatomique. Ce sont des notions qui sont importantes, mais ce sont des notions qui se perdent malheureusement.

J'ai eu l'occasion de faire partie du jury d'internet. Malheureusement, je vois que certaines notions de base, même lorsque les étudiants passent chez nous au service, par exemple en troisième ou quatrième année, et qu'on est au bloc opératoire et qu'on leur pose des questions basiques sur l'anatomie de base des voies biliaires, les réponses ne sont pas là. J'insiste sur ces choses-là parce qu'elles sont importantes.

Ce sont des notions qui sont extrêmement simples à retenir. Vous avez des voies biliaires intra-hépatiques qui suivent la segmentation du foie. Je ne vais pas y revenir parce que c'est un petit peu compliqué.

Je me focalise sur les voies biliaires extra-hépatiques. Les voies biliaires extra-hépatiques, c'est très simple. Vous avez deux canaux hépatiques qui vont collecter la bile produite dans le foie, le canal hépatique droit et le canal hépatique gauche, qui vont se réunir au niveau du île hépatique.

En se réunissant, ils vont former ce qu'on appelle le canal hépatique commun. Le canal hépatique commun va descendre tout le long du pédicule hépatique. À côté, vous avez la voie biliaire accessoire.

La voie biliaire accessoire, c'est la vésicule biliaire et son canal cystique. Elle est accessoire parce qu'elle a un rôle de réservoir. Elle va stocker la bile.

La bile qui est produite dans le foie va être stockée dans ce réservoir qui est la vésicule biliaire.

Au moment de l'alimentation, elle va commencer à se contracter pour évacuer la bile à travers le canal cystique vers la voie biliaire principale. La voie biliaire principale est formée, comme on l'a dit, par les deux canaux hépatiques droit et gauche, puis par le canal hépatique commun.

Une fois que le canal cystique va s'aboucher dans la voie biliaire principale, il changera de nom. Il portera le nom de canal colédoque. Le canal colédoque, c'est la voie biliaire principale après l'abouchement du canal cystique dans le canal hépatique commun.

Ce canal colédoque va cheminer derrière le premier diodénome, puis derrière la tête du pancréas pour aller se jeter au niveau du deuxième diodénome à travers l'ampoule de vapore qui est entourée par le sphincter d'Odie, accompagnée du canal de Virson, qui est le canal hépatique et le canal pancréatique principal. Ce sont des notions de base simples qu'il faut retenir. Vous avez les voies biliaires intra-hépatiques, qui ne nous intéressent pas.

Ensuite, vous avez les voies biliaires extra-hépatiques. Les voies biliaires extra-hépatiques, vous avez les voies biliaires principales et vous avez la voie biliaire accessoire. La voie biliaire accessoire, c'est le réservoir, c'est la visibiliaire et le canal cystique.

La voie biliaire principale, ce sont les deux canaux hépatiques droit et gauche, les canaux hépatiques communs, le canal colédoque qui se jette dans l'ampoule de vapore. C'est assez simple à retenir. La classification est importante.

Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'elle va permettre de distinguer plusieurs types de cancers des voies biliaires. Pourquoi plusieurs types? Parce que chaque type a un traitement particulier. Nous avons trois grosses entités des cancers des voies biliaires.

Nous avons les cholangiocarcinomes qui sont les tumeurs de la voie biliaire principale et éventuellement des voies biliaires intra-hépatiques. Nous avons la deuxième entité, ce sont les cancers de la vésiculobiliaire, de la voie biliaire accessoire à part. Et puis nous avons une entité particulière qui est l'ampulon vaterien.

Le cancer de la vésiculobiliaire, c'est un cancer qui est localisé à la vésiculobiliaire, nous n'allons pas trop le détailler, c'est assez clair. Vous avez la vésiculobiliaire qui peut développer un cancer. Et puis vous avez l'ampulon vaterien.

L'ampulon vaterien, je reviens au rappel anatomique, l'ampulon vaterien, c'est cette région carrefour. Carrefour de quoi? Carrefour du calin colédoc, du calin du versongue, sur la paroi diodénome. C'est une zone très sensible où il y a trois organes qui vont se rassembler et qui peuvent être le siège d'un cancer.

Vous avez un organe légécif, le diodénome, vous avez un organe biliaire qui est le colédoc, et vous avez un organe pancréatique qui est le calin du versongue. Donc chacun de ces organes-là peut développer un cancer et ça porte le nom d'ampulon vaterien par rapport à l'ampoule de

vataire. Troisième entité, ce sont les cholangiocarcinomes.

Dans les cholangiocarcinomes, il faut distinguer les cholangiocarcinomes qui vont se développer en intra-hépatique. Quand vous le savez, si on prend le foie, quand on fait une coupe du foie, vous avez du paroxyme hépatique avec des hépatocytes et puis vous avez des éléments vasculaires. Vous avez des vaisseaux artériels, vous avez des vaisseaux veineux et puis vous avez des voies biliaires.

Donc si le cancer se développe au sein des voies biliaires intra-hépatiques, il portera le nom de cholangiocarcinome intra-hépatique. À côté, nous avons les voies biliaires extra-hépatiques principales qu'on a vues tout à l'heure. Le canal hépatique droit, le canal hépatique gauche, le canal hépatique commun et le canal colédoc.

Donc là, il faut distinguer deux types de cancers. Vous avez les cancers qui sont proximos, proximos, c'est-à-dire qui sont à côté du foie. Donc si vous avez des tumeurs qui sont à côté du foie, ce sont des tumeurs périhilaires.

Ce sont des cancers des cholangiocarcinomes extra-hépatiques proximos. Elles portent un nom particulier, on les appelle les tumeurs de Klatzschin. Donc si vous tapez le nom de Klatzschin sur Internet, sur Google, ça correspond aux tumeurs biliaires ou cholangiocarcinomes extra-hépatiques proximos qui sont juste autour du foie.

À côté, on peut avoir un cancer biliaire qui va se développer à distance du foie, à distance du foie, sur le canal hépatique commun ou sur le canal colédoc. C'est ce qu'on appelle les cholangiocarcinomes extra-hépatiques distaux. Pour se résumer, nous avons trois entités.

Nous avons les cholangiocarcinomes, nous avons les cancers vésiculaires et nous avons les cancers de la vésicule biliaire. Maintenant, le volet épidémiologique, notamment fréquences et facteurs de risque. Alors par rapport à la fréquence, comme on l'a vu, par rapport à d'autres cancers, et heureusement d'ailleurs, les cancers biliaires sont des cancers qui sont relativement rares.

Donc en France, par exemple, vous avez juste 2000 nouveaux cas par an. C'est environ à peine 3% des cancers digestifs. Donc ce sont des cancers qui ne sont pas très fréquents dans le pourtour méditerranéen, mais qui peuvent être fréquents sous d'autres cieux, notamment chez la population asiatique.

Dans la population asiatique, ils sont beaucoup plus fréquents par rapport au pourtour méditerranéen auquel nous adhérons, auquel nous appartenons. Donc c'est rare, heureusement, mais c'est variable. Donc ça, c'est la première notion.

Deuxième notion, c'est la notion d'âge. Souvent, ce sont des cancers qui vont toucher des patients qui sont âgés. Donc les patients qui ont entre 60 et 70 ans.

Et donc ils sont plus fréquents dans cette tranche d'âge, entre 60 et 70 ans. Pour le sexe, il y a une petite différence quand même. Le cholangiocarcinome est prédominant chez les hommes et les cancers de la vésicule biliaire sont prédominants chez la femme.

Donc c'est une notion à retenir. Chez la femme, la femme fait plus de cancers de la vésicule biliaire et l'homme fait plus de cancers de la voie biliaire principale de cholangiocarcinome. Quels sont les facteurs de risque? Le principal facteur de risque, c'est la lithiase biliaire.

C'est pour ça qu'il faut insister et réinsister chez les patients qui ont des calculs biliaires. Ce sont des patients qui doivent être traités. Pourquoi? Parce que le risque de cancérisation d'une lithiase, de faire ce qu'on appelle un néo-calcul visculaire, il est toujours présent.

Donc l'un des principaux facteurs de risque de la maladie cancéreuse biliaire, c'est la lithiase biliaire. D'où l'intérêt de la prévention. Si vous avez un patient qui a une lithiase biliaire, il faut qu'il se fasse opérer, qu'il se fasse enlever sa vésicule biliaire.

Donc ça c'est un. Deuxième facteur de risque, ce sont les maladies inflammatoires chroniques des voies biliaires. Comme nous avons des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, nous avons également des maladies inflammatoires chroniques des voies biliaires.

Et si on a une inflammation chronique des voies biliaires, elle peut faire le lit d'une cancérisation et donc d'une transformation cancéreuse des voies biliaires. De l'inflammation initiale vers un cancer. Nous avons également la consommation d'alcool.

Donc l'alcoolisme est un facteur de risque de la maladie cancéreuse des voies biliaires. Nous avons les infections hépatétiques, notamment l'hépatite virale B et C, qui font augmenter le risque relatif d'environ 5%. Donc si vous avez des patients qui ont des infections hépatétiques virales B et C vers les hépatites chroniques, elles auront un risque d'évoquer un cancer des voies biliaires.

Et puis également les patients qui ont une cirrhose. Donc ça rejoint un petit peu le CHC. Donc si vous avez un patient qui a une cirrhose, le risque augmente de façon significative.

Vous avez un risque relatif supérieur à 20% par rapport à un patient qui n'a pas de cirrhose. Donc la cirrhose est un facteur de risque majeur. Donc nous avons, comme vous pouvez le voir, ce sont pas mal de facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir.

La lithiase biliaire, si elle est diagnostiquée, on peut la traiter. L'alcoolisme, on peut l'arrêter. Les infections hépatites virales B et C, on peut les diagnostiquer et les traiter à temps pour éviter notamment le développement d'une cirrhose, pour ne pas arriver au stade de cirrhose.

Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer un cancer des voies biliaires ? Le diagnostic d'un cancer des voies biliaires, nous allons commencer tout d'abord par les signes

cliniques. Alors malheureusement, les signes cliniques au début, ils sont un petit peu vagues. Ils ne sont pas spécifiques.

Vous avez des dyslexies, vous avez une douleur plus ou moins intense, vous avez des vomissements. Vous avez des signes qui ne sont pas vraiment spécifiques. Et malheureusement, lorsque les signes seront plus spécifiques et lorsqu'ils seront évocateurs, ils seront plus tardifs.

Et s'ils sont plus tardifs, le cancer s'est déjà développé de façon assez rapide. Donc c'est un paradoxe qui est assez contraignant. Vous avez au début des signes qui sont vagues, qui ne sont pas spécifiques.

Mais lorsque les signes deviennent plus évocateurs, malheureusement, le cancer est déjà installé. Donc quels sont ces signes un petit peu évocateurs ? Vous avez tout d'abord l'ictère rétionnelle, qui est d'apparition insidieuse. Donc c'est un ictère qui va s'installer progressivement, mais c'est un ictère qui est d'un seul tenant.

Ce n'est pas comme dans l'hélicéas biliaire, par exemple. Dans l'hélicéas biliaire, vous avez un ictère qui est variable. Dans l'ictère qui est dû au cancer des voies biliaires, c'est un ictère qui est constant et qui est progressif.

Donc c'est un ictère qui est insidieux, qui s'installe progressivement et qui va aller en s'accroissant. Il va progressivement devenir croissant. Et bien sûr, parce qu'il est rétionnel, il va être accompagné d'urines foncées, de sel décoloré et de prurites.

Dans les tumeurs de la voie biliaire principale, bien sûr. Donc lorsque vous avez une tumeur de la voie biliaire, c'est ce que nous allons avoir. Si vous avez une tumeur de la visicule biliaire, vous pouvez ne pas avoir d'ictère.

C'est un paradoxe là aussi. Parce que c'est la voie biliaire principale qui assimile la bile. Donc forcément, si vous avez un obstacle, si vous avez un envahissement de la voie biliaire principale, la conséquence, c'est la stagnation de la bile, c'est l'ictère.

Donc à côté, vous avez bien sûr les douleurs. Les douleurs de l'hépocondrodroite, les douleurs de l'épigastre, qui sont permanentes parce que la tumeur va aller en augmentant de taille. Elles vont irradier vers le dos et qu'elles ne sont pas calmées par les antispasmodiques dans cette tumeur-là.

Donc elles ne sont pas vraiment calmées. Vous avez des signes qui ne sont pas spécifiques. Vous avez des nausées, vous avez des vomissements.

Donc vous avez surtout l'ictère et la douleur. Cette douleur épigastrique, cette douleur de l'hépocondrodroite, irradiation dorsale non calmée par les antispasmodiques, qui sont les deux signes qui sont les plus parlants, les plus spécifiques du cancer des voies biliaires. Alors,

l'examen clinique, qu'est-ce qu'il peut retrouver? Il peut retrouver une hépatomégalie qui correspond soit au cancer lui-même, soit à un foie qui est en train de souffrir, soit à un foie qui est sérotique.

Donc une hépatomégalie. Vous pouvez avoir une masse de l'hypochondrodroite, de l'épigastre, qui correspond au cancer que vous êtes en train de palper. Vous pouvez avoir une ascite qui est en rapport le plus souvent soit par une hépatopathie, par un foie qui est malade, qui est en train de souffrir de son problème biliaire, qui ne peut pas évacuer, soit de la présence d'une carcinose péritoniale.

Dans la carcinose péritoniale, ce sont des métastases qui vont diffuser dans le péritoire et c'est un stade qui est très tardif de maladie. Donc si vous avez une ascite en rapport avec une carcinose péritoniale, c'est malheureusement un stade qui est très avancé de la pathologie. Et bien sûr, vous avez des signes généraux.

Les signes généraux ne sont pas spécifiques à ce cancer-là. Ce sont des signes généraux qui sont retrouvés dans quasiment toutes les maladies cancéreuses. La maigrissement, l'altération de l'état général, l'asténie, l'anorexie, la fièvre.

Donc ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques. La biologie, elle aussi, n'est pas spécifique. La biologie va montrer des signes de souffrance du foie, des signes de non-évacuation de la bile vers le duodenum.

Donc vous aurez un syndrome de cholestase, vous aurez les marques de la cholestase qui seront augmentées, notamment une augmentation des gamma-GT, une augmentation des phosphatases alcalines, une augmentation de la bilirubine totale après dominance directe qui sous-entend que la bile ne peut pas être évacuée correctement vers le duodenum et qu'il est en train de refluer vers le foie et donc vers le sang. Et donc vous aurez un syndrome de cholestase. Syndrome de cytolyse, là aussi, il sous-entend une souffrance du foie.

Vous avez de la bile qui est en train de brûler, qui est en train d'attaquer le parenchyme hépatique et donc vous aurez des transaminases qui sont très augmentées. Vous aurez un syndrome de cytolyse. Vous aurez également des troubles de la coagulation, notamment avec un allongement du temps de Quick et du TP.

Pourquoi ? Parce que le foie, là aussi, il est en train de souffrir, qu'il ne peut pas remplir ses fonctions normalement et donc forcément vous aurez une perturbation du bilan des enzymes. Pour les marqueurs tumoraux, notamment l'ACE et le CA199, ils peuvent être augmentés, mais c'est un constat. Donc c'est un signe qui est un constat et qui n'est pas très spécifique.

Alors maintenant, par contre, l'imagerie. Oui, l'imagerie est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous montrer les tumeurs auxquelles vous êtes en train de penser.

Donc l'échographie tout d'abord. L'échographie, il faut toujours la réaliser en première intention. C'est un examen qui est anodin, c'est un examen qui n'est pas cher, c'est un examen qui est disponible et donc c'est un examen en plus qui va donner pas mal de renseignements, notamment par rapport au foie, par rapport à la vésiculaire, par rapport à la voie biliaire.

Alors l'examen à réaliser en première intention, si vous pensez à ce cancer-là, bien sûr, c'est l'échographie abdominale. En matière de cancer vésiculaire, le diagnostic est quasiment posé dans 80% des cas, rien qu'à l'échographie, d'où l'importance de l'échographie. Donc l'échographie, elle est très importante.

Elle montrera quoi ? Elle montrera qu'il y a des lésions bourgeonnantes, des petits bourgeons, qui vont pousser au sein de la lumière vésiculaire. La vésiculaire, normalement, elle a une lumière qui est translucide, une lumière qui est quasiment homogène, il n'y a rien à l'intérieur, il y a juste de la bile. Dans ce cas, dans le cas du cancer, vous allez avoir des bourgeons, qui vont quasiment occuper la lumière vésiculaire, qui parfois sont tellement gros, qu'ils peuvent occuper toute la vésiculaire et remplacer quasiment toute la vésiculaire.

Ces images-là, on peut les voir à l'échographie. Donc rien qu'en faisant l'échographie, on peut quasiment voir ces bourgeons occuper la lumière vésiculaire et donc évoquer fortement un cancer de la vésiculaire, dans près de 80% des cas. Pour ce qui est de la voie biliaire principale, ça c'est plus difficile.

A l'échographie c'est plus difficile, pourquoi? Parce que la voie biliaire principale, elle est cachée par d'autres organes, notamment par le pancréas, par les gaz. Si vous avez un patient qui a une colopathie, ou si vous avez un patient qui mange un gaz, et puis si vous avez un patient qui est un petit peu obèse, la graisse également, elle peut cacher, elle peut empêcher la diffusion des ultrasons et donc elle empêche d'explorer correctement la totalité de la voie biliaire principale, mais elle peut orienter. Elle peut orienter le diagnostic en montrant une dilatation.

Donc souvent c'est la dilatation qui est retrouvée, notamment la dilatation de la voie biliaire principale ou la dilatation des voies biliaires intrahépatiques, ou les deux. Et donc dans ce cas-là, elle va vous orienter vers un cancer des voies biliaires. Donc souvent, elle n'est pas suffisante pour poser le diagnostic de cancer des voies biliaires, mais elle oriente fortement vers un problème des voies biliaires.

Deuxième examen complémentaire qui est plus poussé, c'est le scanner. Le scanner, il permet de confirmer un diagnostic qui est déjà évoqué par l'échographie. Donc vous avez fait l'échographie, vous avez évoqué un cancer dans la visibilité biliaire.

Le scanner permettra de confirmer ce cancer. Il montrera des bourgeons dans la visibilité biliaire, par exemple. Mais il aura aussi un autre intérêt.

L'autre intérêt, c'est le bilan d'extension et donc la stadification du cancer des voies biliaires. Donc

lorsque vous ferez un scanner, vous verrez à la fois la tumeur et l'extension tumorale. C'est ce qui est très important, c'est ce qu'on ne peut pas voir par l'échographie.

L'échographie, elle est limitée. Le scanner permet d'avoir des images, des coupes qui montreront la visibilité biliaire, qui montreront la tumeur, qui montreront l'extension tumorale. C'est très important.

Voilà. Donc ici, vous avez une image, par exemple, d'un cancer de la visibilité biliaire qui montre un épaissement de la paroi vésiculaire ou bien la présence d'une lésion hypodense qui va prendre le contraste de façon diffuse ou bien en périphérique en cas de nécrocentrale. Sur l'image que vous voyez, sur le scanner que vous voyez un petit peu, vous avez une visibilité biliaire qui est augmentée de taille, qui est un petit peu en train d'avoir des limites qui sont hétérogènes, des limites qui sont plus homogènes, qui est en train d'envoyer son foie.

Vous avez une image centrale qui est hyperdense, qui prend le produit contraste. Et puis, c'est une image assez typique, assez caractéristique d'un cancer de la visibilité biliaire. Le cancer de la voie biliaire principale, il montrera une masse infiltrante ou bien un épaissement d'une paroi, un épaissement mural de la paroi des voies biliaires.

La lésion, elle est soit isodense, soit hypodense avant injection du produit contraste. Et puis, elle aura un rehaussement variable au temps artériel. Donc, vous voyez un petit peu qu'après avoir injecté, nous voyons très bien qu'il y a un épaissement des parois montré par les flèches.

Il y a aussi une dilatation des voies biliaires. Les voies biliaires, elles ne doivent pas être vues à un tel niveau comme ceci. Donc, forcément, il y a une dilatation des voies biliaires.

Il y a des images qui sont très typiques d'un cancer de la voie biliaire. Nous avons vu l'échographie. Nous avons vu le scanner.

Le maître-examen, l'examen le plus important, c'est la biliaire. La biliaire, elle permettra quasiment de cartographier, de montrer une cartographie précise des voies biliaires. Elle vous montrera la visicule biliaire.

Elle vous montrera la voie biliaire. Elle vous montrera quasiment les voies biliaires intra-hépatiques, extra-hépatiques. Et donc, c'est le maître-examen, le maître-examen morphologique à réaliser.

Donc, c'est une technique non-invasive qui permet une cartographie complète. C'est comme si vous aviez une carte précise des voies biliaires. Maintenant, en matière de cancer vésiculaire, l'aspect IRM typique, c'est un carcinome qui sera en hyposignal en T1, en hypersignal en T2, par rapport au signal hépatique.

Donc, vous avez une visicule biliaire qui prend beaucoup de signal en T2. On la voit très bien sur l'image. Donc, c'est une visicule biliaire qui apparaît très opacifiée, qui prend intensivement le

produit de contraste.

C'est très typique d'un cancer de la visicule biliaire. Le cancer de la voie biliaire principale. Donc, vous voyez cette très belle image.

Vous avez une cartographie très précise de la voie biliaire à la fois principale et accessoire. Donc, vous avez une dilatation. Vous voyez très bien qu'on suit un petit peu l'arbre biliaire progressivement.

C'est un arbre biliaire qui est dilaté. Ce n'est pas l'aspect typique. Ce n'est pas l'aspect normal.

Vous avez un arbre biliaire qui est dilaté Pourquoi est-ce qu'il est dilaté ? Si vous suivez un petit peu l'arbre biliaire, vous arrivez vers le bas. Vous avez une interruption brutale de l'opacification qui sous-entend qu'il y a une sténose à ce niveau-là et qui sous-entend bien sûr la présence d'un cancer à ce niveau-là. Vous avez en 1 également la présence de la visicule biliaire qui paraît distendue.

Pourquoi ? Parce qu'il y a ce reflux de bile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cancer en bas, sur la partie basse de la voie biliaire principale qui empêche la progression du cancer et qui évoque fortement une sténose tumorale de la voie biliaire principale. C'est la méthode de choix, l'IRM, pour revenir un petit peu à ce qui était écrit sur la diapositive.

C'est la méthode d'imagerie de choix dans les sténoses malignes biliaires, surtout pour les sténoses proximales. Cette opération n'est difficile, voire impossible, par les autres techniques d'imagerie. Vous avez vu votre patient en consultation.

C'est un patient qui a un nictère. C'est un patient qui a une douleur. C'est un patient qui a une masse abdominale à l'examen clinique.

Vous avez demandé une échographie qui vous a évoqué le diagnostic. Vous avez fait un bilan hépatique qui a montré un certain nombre de cholestases, un certain nombre de symptômes hépatiques. Vous avez complété par un scanner et une bilirem qui ont fortement évoqué le cancer de la voie biliaire.

Que faut-il faire par la suite ? Vous êtes en face d'un cancer. Il faut faire un bilan préthérapeutique. Avant de proposer le patient pour un traitement, il faut lui proposer un bilan préthérapeutique.

Le bilan préthérapeutique, comme pour tous les cancers, c'est le bilan d'opérabilité et le bilan de réséquabilité. Quand on veut traiter un patient qui a un cancer, on se pose toujours deux questions. Est-ce que le patient est opérable ? Est-ce qu'il va supporter une anesthésie générale ? Est-ce qu'il va supporter un geste chirurgical lourd ? Est-ce qu'il est opérable ? Et puis, s'il est opérable, s'il va supporter tout ça, est-ce qu'il est réséquable ? Est-ce que sa tumeur peut être

réséquée ? Est-ce qu'on peut proposer un traitement curatif à ce patient ? Est-ce que lorsque je vais faire ma laparotomie, je vais pouvoir enlever tout le cancer ? C'est ce qu'on appelle la réséquabilité.

Le bilan préthérapeutique, il a ces doubles vues, ces doubles objectifs. D'une part, poser la question d'opérabilité. D'autre part, poser la question de réséquabilité.

En matière d'opérabilité, que faut-il faire ? Il faut tout d'abord examiner le patient, faire un examen clinique du patient, évaluer l'état général du patient, évaluer son IMC, évaluer son poids, évaluer le panamyclisme intense que présente le patient. Il faut faire un bilan biologique, voir les grandes constantes, faire une NFS, voir s'il n'y a pas d'anémie, faire un bilan des moustases, faire une protidémie. Il faut que le patient passe, bien sûr, chez le médecin anesthésiste pour évaluer, pour faire une visite préanesthésique, notamment faire un ECG, faire une radiographie thoracique, pour évaluer si le patient supportera une anesthésie.

Et il faut faire une volumétrie hépatique scanographique. C'est ce qu'on avait précisé lors de l'autre cours, lorsqu'on avait traité des tumeurs hépatiques. La volumétrie juge un petit peu le volume hépatique.

Et juste, si on résèque une partie du foie, est-ce que le foie qui va rester pourra assumer les fonctions vitales du patient ? C'est une question qu'on se pose, et c'est une question à laquelle on a une réponse en faisant la volumétrie scanographique du foie. Donc ça, c'est pour l'opérabilité du patient. Si le patient est opérable, la question suivante qui va se poser, c'est la résécabilité de la lésion.

Est-ce que le cancer sera résécable ? Est-ce que je pourrais couper le cancer ? Si j'ouvre le patient, est-ce que je pourrais enlever en totalité le cancer ? Est-ce que je serais dans le curatif ? Ou bien, est-ce que je ne pourrais pas enlever le cancer ? Et dans ce cas-là, on va s'aider à la fois par la colonge IRM ou la bilie IRM pour voir l'extension du cancer sur l'arbre biliaire. Donc ça, c'est un. Et puis également, en faisant un scanner thoraco-abdominopelvien pour voir s'il n'y a pas de métastase, pour voir s'il n'y a pas une autre localisation tumorale, soit dans le thorac, soit dans l'abdomen, soit dans le pelvis.

Et donc ça, c'est pour la résécabilité. Donc retenez-là, ces notions-là, elles sont importantes pas seulement pour ce cancer, pas seulement pour ce cours-là, pour tous les cancers. Opérabilité et résécabilité du cancer.

Maintenant, pour le traitement, à proprement parler, comment peut-on traiter ces patients qui ont un cancer des biliaires ? Traitement, nous disposons de plusieurs moyens thérapeutiques. Nous disposons de la chirurgie, nous pouvons opérer ces patients. Nous disposons de traitements médicaux et médicamenteux pour traiter ces patients.

Et nous disposons de moyens endoscopiques pour traiter nos patients. Les traitements

médicaux, ce sont des traitements essentiellement symptomatiques. Des traitements antalgiques contre la douleur, des traitements anti-hémétiques contre les vomissements, des transfusions lorsque le patient est anémique ou qu'il a des troubles d'hémostase.

Donc ce sont des traitements symptomatiques, purement symptomatiques. La chirurgie, retenez-le, c'est le seul traitement potentiellement curatif pour les cancers dévoid biliaires. Si vous voulez guérir un patient qui a un cancer, si vous prétendez guérir un patient qui a un cancer dévoid biliaire, le seul traitement que vous pouvez lui proposer, c'est la chirurgie.

La chirurgie, c'est la résection de la tumeur. La transplantation hépatique, elle est juste au stade de ces thérapeutiques, il n'y a pas d'indication formelle. Ce n'est pas comme le cours que nous avons vu tout à l'heure pour les CAC, pour les tumeurs hépatiques.

Les tumeurs hépatiques, elles ont des indications formelles pour la transplantation hépatique. Les tumeurs biliaires, on est juste au stade de ces thérapeutiques, il n'y a pas d'indication formelle pour faire une transplantation hépatique chez ces patients-là. Donc deux notions très importantes.

La chirurgie est le seul traitement curatif en matière de cancer dévoid biliaire, c'est très important. La transplantation hépatique est ces thérapeutiques, il n'y a pas d'indication formelle. Donc pour la chirurgie, à proprement parler, le geste dépendra du siège de la tumeur.

Donc nous avons vu que la tumeur peut siéger au niveau intra-hépatique, ça peut être une tumeur hépatique. La tumeur peut siéger au niveau du hile du foie. La tumeur peut siéger au niveau du pudicule hépatique.

La tumeur peut siéger au niveau de l'ampoule de vataire. La tumeur peut siéger au niveau de la visée biliaire. Et donc le geste dépendra du siège de la tumeur, tout simplement.

Donc si vous avez une tumeur à développement intra-hépatique, le geste à proposer, ce sont les hépatectomies. Donc ça rejoint ce que nous avons vu pour les tumeurs hépatiques. Donc c'est une tumeur hépatique qu'il faut proposer le patient. Si vous avez une tumeur au niveau du hile, il faut procéder à une résection de la veublière principale, plus ou moins résection hépatique.

Donc si la tumeur est un petit peu à cheval sur le foie, il faut à la fois emporter la partie du foie tumorale et emporter la veublière principale. Il faut emporter la partie de la veublière principale qui est atteinte. Si vous avez une tumeur qui est franchement en extra-hépatique, il faut enlever la visée biliaire systématiquement et enlever la partie de la veublière principale qui est atteinte, la partie de la veublière principale qui est touchée par la tumeur.

L'image que vous voyez montre une tumeur de la veublière principale en extra-hépatique qui a provoqué une sténose. Le geste consiste en une résection. Première image, la tumeur est là.

Deuxième image, on a réséqué la tumeur. Troisième image, on a rétabli le circuit de la bile. On a

fait monter une once intestinale, une once vésigénale pour la brancher sur les veublières.

Pour ce qui est du cancer de la vésicule biliaire, il y a deux gestes qui peuvent être proposés. Vous pouvez enlever la vésicule biliaire et avec elle, la partie du lit vésiculaire à laquelle adhère la vésicule biliaire. C'est un geste à minima qui est proposé pour les cancers qui sont débutants, qui sont de petite taille.

Lorsque le cancer prend du volume, lorsqu'il devient trop gros, il faut faire une hépatectomie. Il faut enlever toute la partie du foie qui est à côté de la vésicule biliaire, une bisegmentectomie, on appelle ça le segment 4 et 5 du foie, en emportant la vésicule biliaire. Il faut faire une bisegmentectomie ou hépatectomie en portant la vésicule biliaire.

Lorsque vous avez un ampulon vatérien, l'ampulon vatérien c'est une tumeur, comme on l'a dit, carrefour, c'est une tumeur sur la face interne du deuxième duodenum. Le deuxième duodenum est en rapport avec la vésicule, avec la veublière principale, avec le canal de version qui est surtout avec la tête du pancréas. On ne peut pas enlever la tumeur sans enlever l'un et l'autre.

Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle une diodénopancréatectomie céphalique, ce qu'on appelle DPC, diodénopancréatectomie céphalique, c'est-à-dire qu'on va emporter le duodenum, la tête du pancréas et également la veublière principale qui est atteinte par le cancer. On appelle ça la DPC, diodénopancréatectomie céphalique. Alors, toujours en matière de chirurgie, la résurrection chirurgicale doit respecter ce qu'on appelle des marges R0.

R, c'est résidu tumorale. Il ne faut pas qu'il y ait un résidu tumorale. Donc si j'enlève ma tumeur, je ne dois pas laisser en place un résidu tumorale.

Si je laisse en place un résidu tumorale, ce sont des cellules tumorales. Si je laisse en place des cellules tumorales, je ne suis plus dans le curatif. Donc forcément, si je veux proposer le patient pour un traitement lourd chirurgical, la seule condition c'est que je dois être dans le curatif.

Je ne dois pas laisser le résidu tumorale. Si je laisse le résidu tumorale, ce n'est pas la peine de faire le geste. Parce que si tu laisses un résidu tumorale, la tumeur va revenir.

Tu vas exposer le patient à un traitement chirurgical qui est lourd sans pouvoir guérir le patient parce que tu as laissé un cancer en place. Dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de faire un traitement curatif. Dans ce cas-là, il faut se contenter de faire une dérivation biliaire.

Il ne faut pas proposer le patient pour un chirurgie curative. Ce sont des petites notions que je vous dis. Ce sont des notions techniques.

Vous ne serez pas évolués par rapport à ça parce que ce sont des choses qui sont un peu techniques par rapport à votre niveau. Mais ce sont des choses qui sont importantes à connaître. Donc, si je peux réséquer la tumeur sans laisser le cancer, oui, je fais la résection.

Mais si je laisse un résidu tumorale, ce n'est pas la peine de réséquer. Je fais une dérivation. Je fais monter une lance intestinale au niveau du pédicule hépatique pour dériver la bile et c'est tout.

Donc, je ne prétends pas guérir le patient. La résection, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la résection qu'on va faire sur le patient que la survie du patient statistiquement va changer.

Donc, si j'arrive à réséquer la tumeur, là, c'est une notion qui est un peu méchante parce que vous allez voir par la suite les statistiques. Même si j'arrive à enlever la tumeur R0, la survie à 5 ans ne dépasse pas les 10% pour un cancer de la vésiculopédie. Elle ne dépasse pas les 40% en matière de cholangiocarcinome.

Donc, ça, c'est si je réalise la chirurgie idéale sans même laisser le résidu tumorale. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse ce sont des cancers qui ont un pronostic qui est très fâcheux. Donc, en faisant un geste idéal chirurgicalement, la survie ne dépasse pas globalement 40%.

Donc, c'est un cancer qui reste malheureusement très méchant. Alors, à côté du traitement médical et du traitement chirurgical, nous avons un traitement endoscopique. Le traitement endoscopique n'a pas pour but de guérir le patient, d'enlever le cancer.

C'est un traitement qui est palliatif. Le but du traitement endoscopique, c'est de permettre à la bile de passer, tout simplement, en permettant un accompagnement du patient, tout simplement, mais sans guérir le cancer. Comment cela est possible ? Cela est possible en mettant en place des prothèses, des prothèses biliaires.

Les prothèses biliaires, ce sont des prothèses comme vous voyez sur les images, qui vont permettre l'évacuation de la bile de la veau biliaire principale vers le duodenum en laissant la tumeur en place. C'est un traitement qui est temporaire. Pourquoi ? Parce que vous devinez très bien que la tumeur continuera à pousser et en continuant à pousser, elle va envahir la prothèse et donc cela ne va plus passer.

C'est un traitement qui est provisoire, qui dure 3 mois, 4 mois, 6 mois, en fonction des patients. Il est proposé pour les patients qui ne sont pas réséquables et les patients qui sont inopérables. On met en place des prothèses biliaires qui peuvent être en plastique ou des prothèses métalliques.

C'est un traitement palliatif proposé au cas par cas chez certains patients. Je vous ai dit que c'est un cours qui n'est pas très long. Je n'ai pas voulu trop le détailler.

C'est un cours sur lequel on s'est focalisé sur les choses qui sont essentielles et principales. En conclusion, on peut dire que malgré le progrès des investigations radiologiques, les chronologies au cas assis, malheureusement, sont souvent diagnostiqués à des stades avancés ou tardifs. Pourquoi ? Parce que les signes cliniques ne sont pas spécifiques.

Forcément, lorsqu'on arrive au stade de diagnostic, malheureusement, ce sont souvent des patients qui sont à un stade qui est avancé et dont le pronostic est assez réservé. Deuxième notion très importante en conclusion, c'est que la chirurgie reste le seul traitement curatif chez ces patients-là. Pour guérir le patient, il faut l'opérer, il faut le proposer par la chirurgie.

Tous les autres traitements sont palliatifs. Troisième notion malheureuse, c'est que globalement, c'est un cancer qui a un pronostic qui est très mauvais. Nous l'avons vu, 5%, 10%, 40% pour les cancers qui sont à R0, pour les cancers qui ont été opérés, pour les cancers qui ont été enlevés.

C'est un cancer qui reste, malheureusement, globalement, de pronostic très fâcheux. Sur ce, je vous souhaite un très bon courage et à très bientôt.